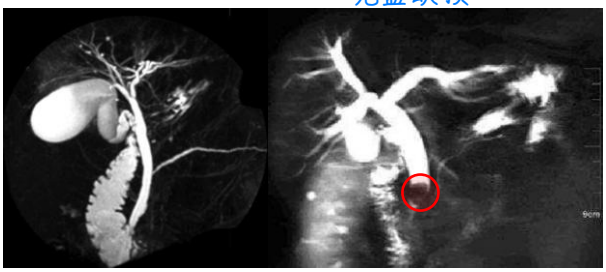
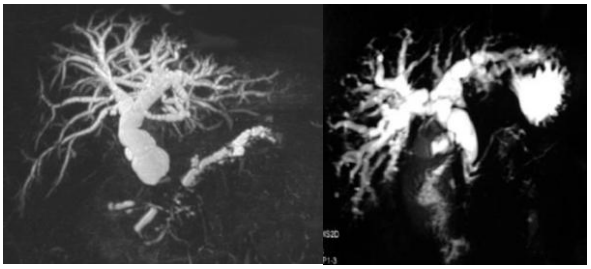
充盈缺损

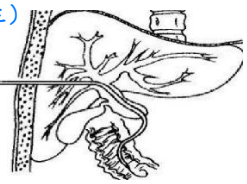


杯口征（结石）



偏良性病变:枯树征/残根征
病程长,纤维化明显,僵硬,堵的不严重

软藤征(偏恶性)
病程急,纤维化不严重,胆管比较柔软,堵的严重



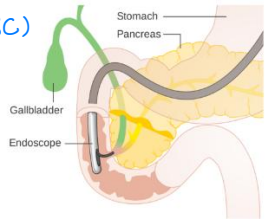
3.经皮经肝胆管穿刺造影 PTC

①不受肝功能影响：即使黄疸重、肝功能差者也能用 与胆囊造影对比

②PTC 检查后需引流（经皮经肝胆管穿刺引流 PTCD）：兼**诊断和治疗**作用

减压(如AOSC)

③并发症：胆瘘、出血、感染等



4.经内镜逆行性胰胆管造影 ERCP

①意义：检查、取活检、取石（内镜下 Oddi 括约肌切开术 EST）

②ERCP 检查后需引流（鼻胆管引流 ENBD）：兼**诊断和治疗**作用 减压

③**并发症**：急性胰腺炎（偏左上腹痛）、急性胆管炎（偏右上腹痛+黄疸）、穿孔、出血、感染等

胰管压力↑　Charcot三联征

（五）胆总管探查术 怀疑胆总管有问题

有可能掉到胆总管里面

1.指征：小的胆囊结石，胆总管梗阻，梗阻性**黄疸**、胆总管结石、蛔虫、肿块，**胆总管扩张＞10mm**、胆管壁明显增厚，反复发作胆绞痛、胆管炎、胰腺炎、胰头肿物，胆管穿刺抽出脓性、血性胆汁、泥沙样胆色素颗粒

会对胆管造成压迫甚至浸润

2.胆总管探查后常规 T 管引流 胆总管探查后会对胆总管造成损伤,会有纤维化,生成的瘢痕会引起狭窄,所以要引流

①T 管的意义：作为支撑预防胆管狭窄、引流保持胆管通畅、减少胆汁刺激 Oddi 括约肌利于其炎症消退、减低胆管压力利于切口愈合和预防胆瘘、待纤维窦道形成后经其取出残余结石

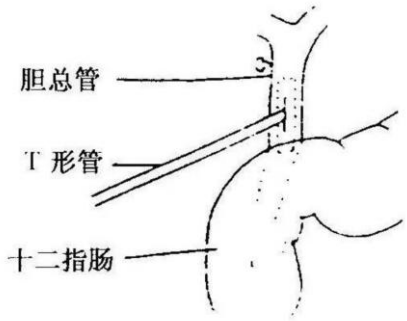
T管为异物,刺激周围纤维组织增生

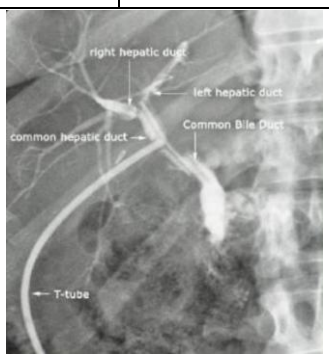
严格来说应是瘘管(一端是皮肤开口,一端是胆管)

②放置 T 管后：

观察胆汁引流的性状	澄清
观察胆汁引流的量 肝分泌胆汁1000ml/d 胆囊接纳胆汁500ml/d（**200-300**ml/d）	若无胆汁引出→检查 T 管本身 若胆汁引出过多→**T 管远端胆管梗阻** 确保没问题
术后 **2** 周 T 管造影	若胆道通畅继续引流 1 天→关闭 T 管（**闭管**）
胆道无结石残留→术后 **4** 周**拔管** 胆道有结石残留→术后 **4**-8 周胆管镜**取残余结石**	拔管太早会导致胆汁性腹膜炎 （250-2B 是吧）
低脂饮食	T 管引流不利于患者消化功能恢复

①闭管:胆汁被引走会影响消化
②不拔管:此时纤维窦道没有形成,胆汁漏出会导致胆汁性腹膜炎





T管造影

